



HIGIENE E CONFORTO

Semiologia e Semiotécnica I

HIGIENE E CONFORTO

- Higiene - são os cuidados que temos com o corpo. Esse tipo de higiene além da prevenção normal contra doença tem a função de causarmos boa impressão aos outros. Influenciando diretamente na comunicação e no relacionamento interpessoal.
- Conforto – é o estado em que um indivíduo sente-se aliviado de um sofrimento. Um dos fatores que contribui para o conforto é um ambiente seguro, limpo e atraente.

A boca mal cuidada favorece o aparecimento de infecção, tanto no trato digestivo quanto no trato respiratório, por isso, a higiene oral constitui um cuidado de

Higiene do Paciente Hospitalizado – Higiene Oral

Objetivos:

- Motivar a formação de hábitos de higiene;
- Remover restos alimentares;
- Prevenir cáries dentárias e infecções (mucosites, endocardite);
- Proporcionar conforto e bem-estar.



Higiene do Paciente Hospitalizado

Está inserida em tipos de higiene: oral, capilar, pessoal, íntima e tem uma importância na recuperação do paciente para prevenir doenças.

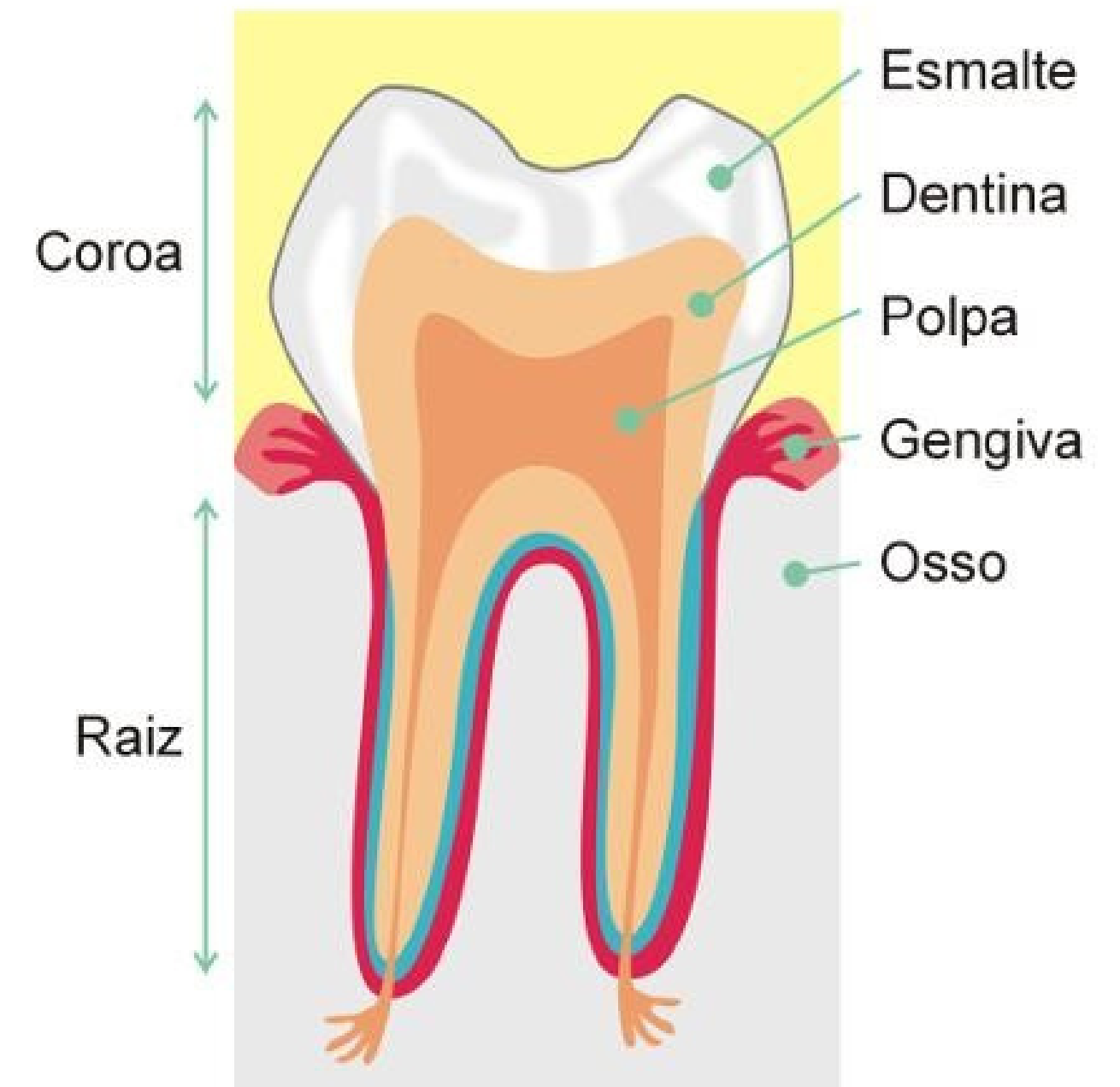
Higiene Oral:

A boca é a principal porta de entrada para os micro- organismos causadores de doenças. Excelente meio de incubação porque fornece umidade, alimento, calor e proteção em condições ideais.



Os dentes, cujo esmalte é uma estrutura de queratina, estão presentes logo abaixo das gengivas ao nascimento. A porção exposta de cada dente é conhecida como *coroa* e a porção dentro da gengiva, *raiz*.

Os dentes começam a nascer por volta dos 6 meses de idade e continuam a surgir durante dois anos ou mais. À medida que a mandíbula se expande, os *dentes decíduos*, ou de leite, são substituídos pelos *dentes permanentes*. Os adultos possuem de 28 a 32 dentes permanentes, dependendo de terem ou não os terceiros molares, chamados “*dentes do juízo*”.



Dentes saudáveis estão firmemente presos no interior das gengivas. Seu alinhamento que possui relação com a estrutura mandibular, costuma ser resultante da hereditariedade. Embora os dentes, originalmente, sejam brancos, podem descolorir em consequência de medicamentos, como antibióticos, consumo crônico de café ou chá e uso do fumo.

A integralidade dos dentes depende em grande parte das práticas de higiene oral do indivíduo, sua alimentação e sua saúde geral.

O acúmulo de resíduos alimentares especialmente açúcar e a *placa* composta de mucina e outras substâncias granulares na saliva, estimulam o crescimento de bactérias orais = **CÁRIE**.

Abcesso
Amigdaliano



**Agenesia
Dentária**



Tabela 2. Causas de halitose. Esta tabela resume as diferentes causas de halitose.

Localização	Frequência	Doenças
Cavidade oral	90%	cárie dental, doença periodontal, saburra lingual, polpa dental exposta, feridas em cicatrização, impacção alimentar, próteses e restaurações mal adaptadas, ulcerações, fistulas, lesões neoplásicas.
Doenças otorrinolaringológicas e respiratórias	8%	faringite, tonsilite, sinusite, corpo estranho na cavidade nasal ou sinusal, bronquite, neoplasias.
Doenças do sistema digestivo	1%	síndromes de má absorção, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite, hérnia hiatal, infecção por <i>Helicobacter pylori</i> .
Outras	1%	insuficiência renal, halitofobia, trimetilaminúria, diabetes.



Grau de Mucosite Oral	Comorbidade para a mucosa oral
Grau 0	Sem alterações
Grau 1	Eritema, irritação, dor
Grau 2	Eritema, úlceras (dieta sólida)
Grau 3	Úlceras (dieta líquida)
Grau 4	Impossibilidade de alimentação

HIGIENE ORAL



Procedimentos:

Material: escova de dente; dentifrício (pasta dental); copo descartável com água; toalha de rosto; cuba rim; espátula; canudo SN; antisséptico oral; luva de procedimento; gaze.

Paciente com pouca limitação:

1. Em posição de Fowler e com a cabeça lateralizada;
2. Proteger o tórax com a toalha de rosto;
3. Colocar a cuba rim sob a bochecha;
4. Solicitar para que abra a boca ou abri-la com auxílio da espátula;
Utilizar a escova com movimentos da raiz em direção à extremidade dos dentes. Fazer cerca de 6 a 10 movimentos em cada superfície dental, com pressão constante da escova;
Repetir esse movimento na superfície vestibular e lingual, tracionando a língua com espátula protegida com gaze,
6. Oferecer copo com água para enxaguar a boca; utilizar canudo s/n.

Paciente com prótese:

1. Solicitar que retire a prótese ou fazer por ele, utilizando a gaze; colocá-la na cuba rim;
2. Escovar a gengiva, palato e língua, se o paciente não puder fazê-lo;
3. Oferecê-la para que o paciente coloque-a ainda molhada.

Pacientes inconscientes ou em estado grave:

4. Toalha sobre o tórax e proteger a cama;
5. Elevar decúbito se não houver contra indicação;
6. Molhar a gaze na solução;
7. Lavar dentes, gengivas, palato, bochechas, língua;
8. Lubrificar lábios;
9. Aspirar cavidade oral;
10. Deixar paciente confortável.



Higiene Oral no Paciente Crítico



<https://www.youtube.com/watch?v=aQeAd-4kNsA>

O Projeto de Lei 883/19 torna obrigatória a presença de profissionais de odontologia na equipe multiprofissional das unidades de terapia intensiva (UTIs), de clínicas e hospitais públicos ou privados em que existam pacientes internados.

Higiene do Paciente Hospitalizado –

Tomar banho é uma prática de higiene em que são utilizados sabão e água para remover o suro, oleosidade, poeira e os micro-organismos da pele. Embora a restauração da limpeza seja o principal objetivo do banho, há vários outros benefícios dentre eles:

- Eliminação de odores desagradáveis do organismo;
- Redução do potencial de infecções
- Estimulação da circulação
- Oferecimento de sensação refrescante e relaxante
- Melhora da auto estima.

Sempre que possível, o banho deve ser no chuveiro, mesmo com o uso de cadeiras próprias para atividade.

O leito só deve ser usado para o banho quando o paciente não tiver qualquer condição de se mover.



Tipos de Banho:

Banho de Aspersão: **banho no chuveiro**, quando uma pessoa está com algum problema de saúde, mas não tem dificuldades de tomar banho de chuveiro a aspersão é a melhor técnica. Podendo ser com auxílio de um profissional ou sem, dependendo as condições que o paciente está.

Banho de Imersão: trata-se do **banho em banheira**, pode ser mais confortável para pacientes que tem dificuldade de ficar em pé para o banho de aspersão.
Banho dos recém-nascidos.



BARRAS DE APOIO

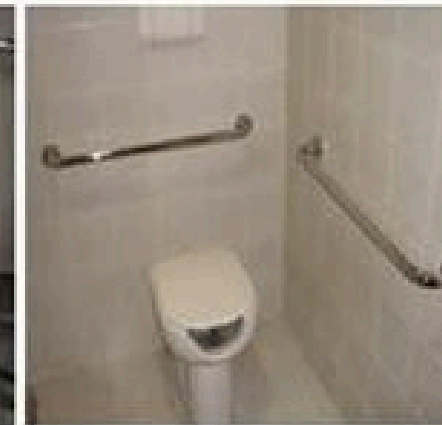
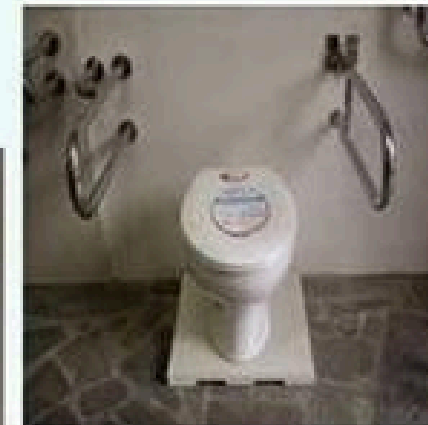
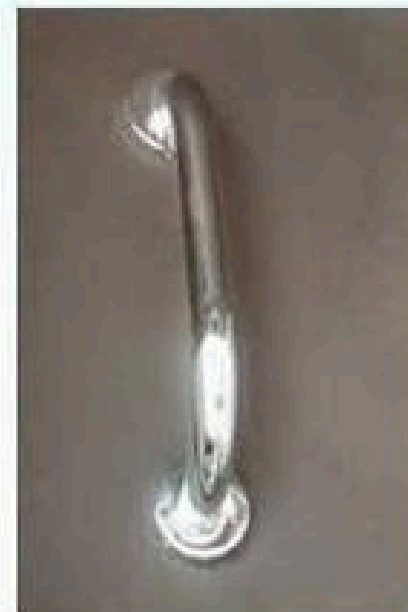
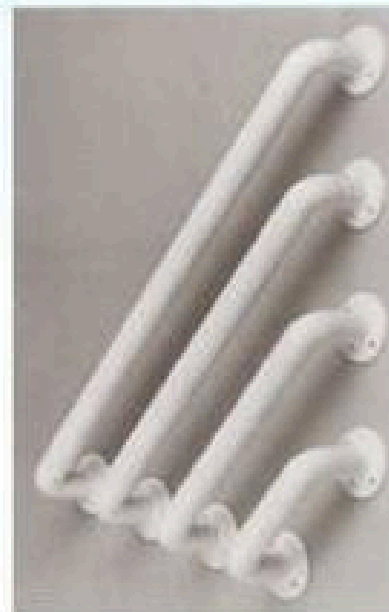
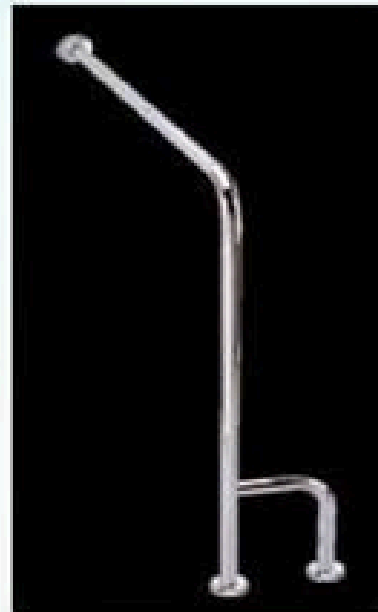
Barras de Apoio desenvolvidas para dar segurança e auxiliar as pessoas que necessitam de apoio para levantar-se ou sentar-se no banheiro.

Indicações:

Paraplegia e Geriatria. Proporcionar estabilidade e conforto para pessoas que necessitam de um auxílio para se movimentar durante o banho em casa ou no uso do vaso sanitário.

Característica:

- Barras de Apoio de Todos os Tipos e Tamanhos;
- Barras de Apoio Brancas, Inóx Polido e Escovado.



Banho de Ablução: consiste num tipo de banho que são jogadas porções pequenas de água sobre o corpo. Também chamado de Banho Parcial podendo ser feito no leito.

Banho no Leito: procedimento realizado em pacientes que se encontram acamados e que necessitam de repouso absoluto. Feitos em casos de pacientes graves, sedados, inconscientes, com alguma mobilidade física, idade avançada, cirurgia recente que necessite repouso, absoluto no leito.

ASPERSÃO



BANHO NO
CHUVEIRO

IMERSÃO



BANHO NA
BANHEIRA

ABLUÇÃO



BANHO EM
PEQUENAS
PORÇÕES DE ÁGUA

BANHO NO LEITO



BANHO EM PACIENTES ACAMADOS EM
REPOLSO ABSOLUTO

Banho de Leito - Cuidados

Técnica: o banho deve obedecer ao sentido cefalocaudal, deixando para a última etapa as partes íntimas e a região anal.

- Risco de hipotermia: evitar que o paciente permaneça exposto a baixas temperaturas, por isso todo o processo deve ser feito no máximo em 20 minutos, pois o frio pode ser prejudicial ao quadro clínico.
- Risco de infecções: deve-se usar materiais de uso individual, preferencialmente produtos descartáveis. Nunca reutilizar a água da bacia que esteja com sujidade de substâncias orgânicas para lavar outra parte do corpo.

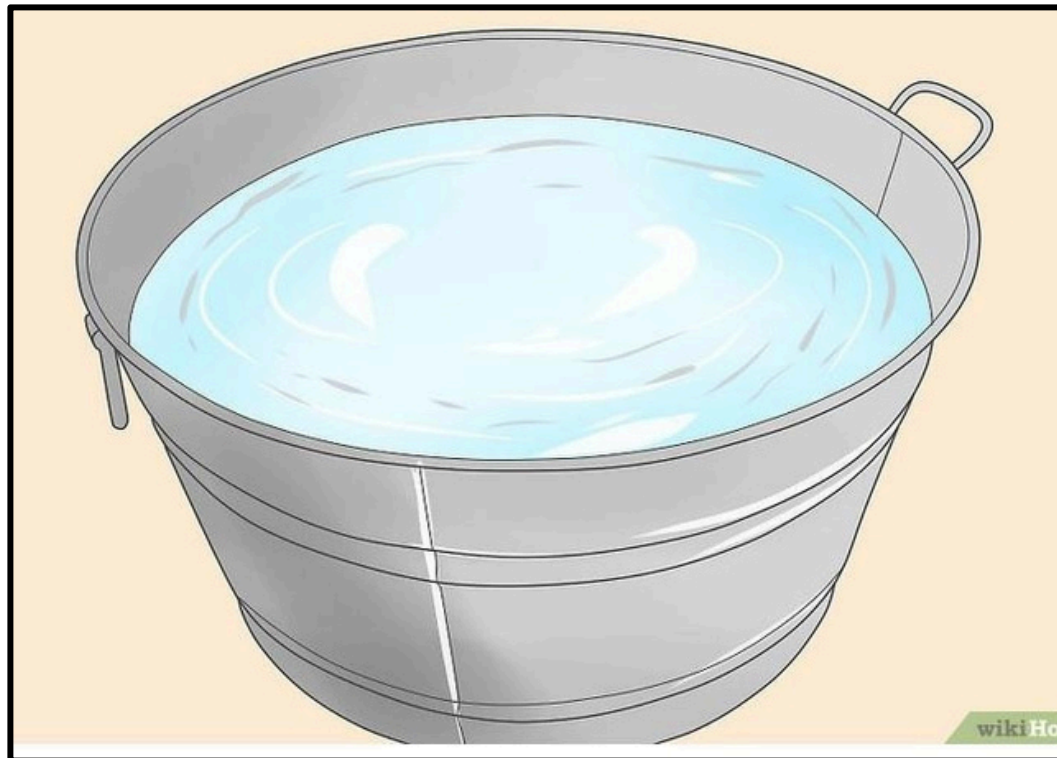
– Dispositivos: o profissional precisa atentar-se a cateteres, drenos, sondas e cânulas de intubação inseridos no paciente, principalmente na UTI, para não movê-los ou retirá-los na hora da higienização.

- **Instabilidade da respiração:** o enfermeiro deve avaliar as condições respiratórias:

Verificar exame de raios-X do tórax do paciente, monitorização, oximetria e demais parâmetros;



- Risco de quedas: importante realizar a avaliação das condições psicomotoras do paciente, como agitação, confusão mental, nível de sedação e superfície corpórea. O paciente necessita estar calmo e a equipe assistencial preparada para não realizar movimentos bruscos e garantir a movimentação do paciente com segurança. As camas devem ter travas nas rodas e grades para diminuir o risco de queda.



1 Encha duas bacias ou tanques com água morna. Uma será usada para lavar, e a outra para enxaguar. A temperatura da água deve ser de 46 °C ou mais baixa. A água deve ser agradável ao toque, não quente demais.



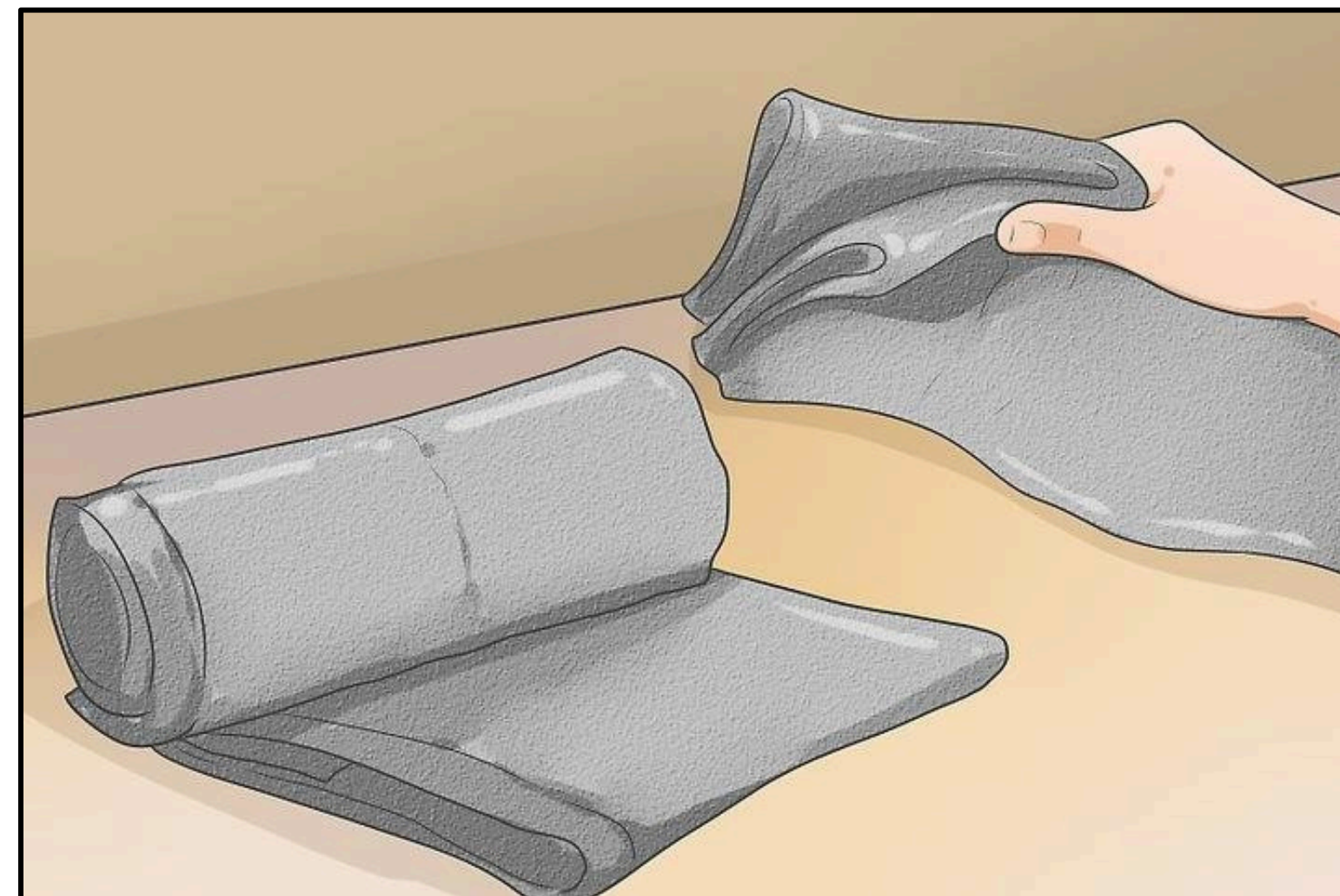
2 Escolha um sabonete que seja fácil de enxaguar. A maioria dos sabonetes em barra são assim. Os líquidos também são aceitáveis desde que não deixem resíduos. Você pode colocar sabonete em uma das bacias para a lavagem ou então mantê-lo separado e aplicá-lo diretamente na pele do paciente.

- Evite usar sabonete que tenha partículas exfoliantes ou outras substâncias que possam ficar na pele do paciente e causar uma irritação.
- As drogarias disponibilizam sabonetes sem enxágue. Essa é uma solução conveniente para uma limpeza mais leve, porém ela deixa resíduos e você ainda terá que enxaguar o corpo do paciente de vez em quando.



3 Deixe os produtos de cabelo prontos. Caso planeje lavar os cabelos do paciente, você precisará de um xampu fácil de enxaguar (como os de bebês) e uma bacia especial feita para fazer isso na cama. Você pode encontrar uma dessas em uma loja de equipamentos médicos, e ajuda bastante.

- Se não tiver uma bacia especial, é possível criar uma colocando uma ou duas toalhas extras embaixo da cabeça do paciente para proteger a cama da água.



4 Tenha uma pilha de toalhas de banho e de rosto limpas à disposição. Você precisará de três toalhas de banho e duas de rosto, no mínimo, mas é bom ter extras caso derrame água ou os materiais fiquem sujos.^[1]

- É útil empilhar toalhas de banho, de rosto, as bacias de água e o sabonete em um carrinho portátil, como um carrinho de TV, para que você possa manter tudo de que precisa perto da cama.



5 Coloque duas toalhas embaixo do paciente. Isto evitará que a cama fique molhada e manterá o paciente confortável durante o processo. Para colocar as toalhas embaixo do paciente, vire-o de lado e ajeite a toalha embaixo, depois, com cuidado, solte o paciente e faça o mesmo do outro lado.



6 Cubra o paciente com um lençol ou toalha limpos. Este passo é para garantir que o paciente fique aquecido durante o banho ao mesmo tempo em que dá um pouco de privacidade. O lençol ou toalha ficará sobre o corpo do paciente durante todo o tempo.

- Ajuste a temperatura do quarto para evitar que o paciente sinta frio.



7 Retire as roupas do paciente. Dobre o lençol ou toalha, deixando a parte superior do corpo descoberta, e retire a camisa da pessoa. Recoloque o lençol. Agora, dobre-o na parte que cobre as pernas e remova as calças e roupa íntima do paciente. Torne a cobri-lo.^[2]

- Tente manter o paciente o mais coberto possível enquanto você retira as roupas dele.
- Tenha em mente que este processo pode ser constrangedor para algumas pessoas, portanto tente trabalhar rapidamente e com uma atitude resoluta.

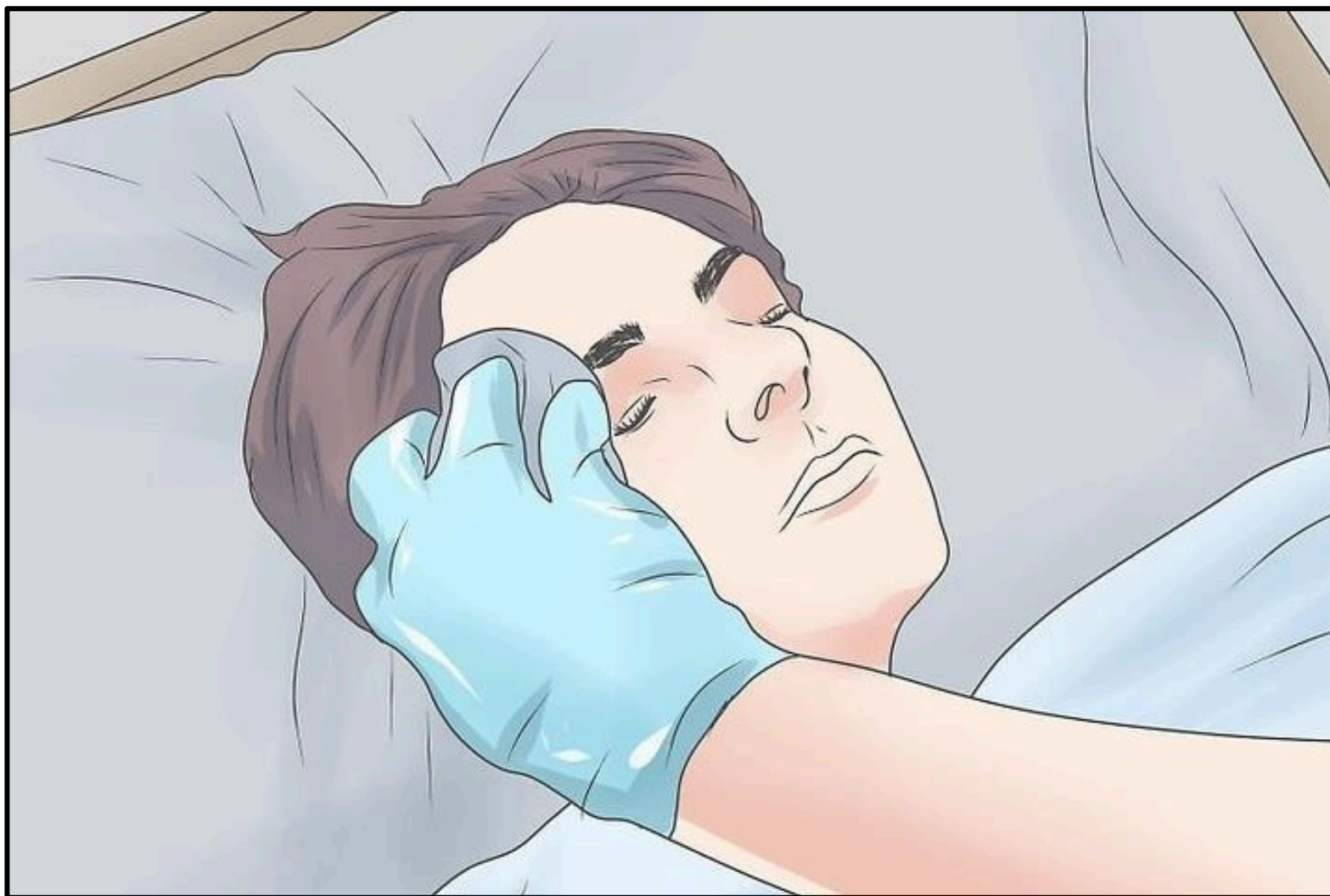


Parte
2

Banhando a cabeça, tórax e pernas

1 Use o mesmo método de limpeza e enxágue para todo o corpo. Primeiro aplique o sabonete ou água com sabão sobre a pele do paciente. Esfregue gentilmente com uma toalha de rosto para remover a sujeira e as bactérias, então coloque a toalha na bacia correspondente. Mergulhe uma segunda toalha de rosto na bacia de enxágue e use-a para retirar o sabonete. Seque com leves toques com uma toalha seca.

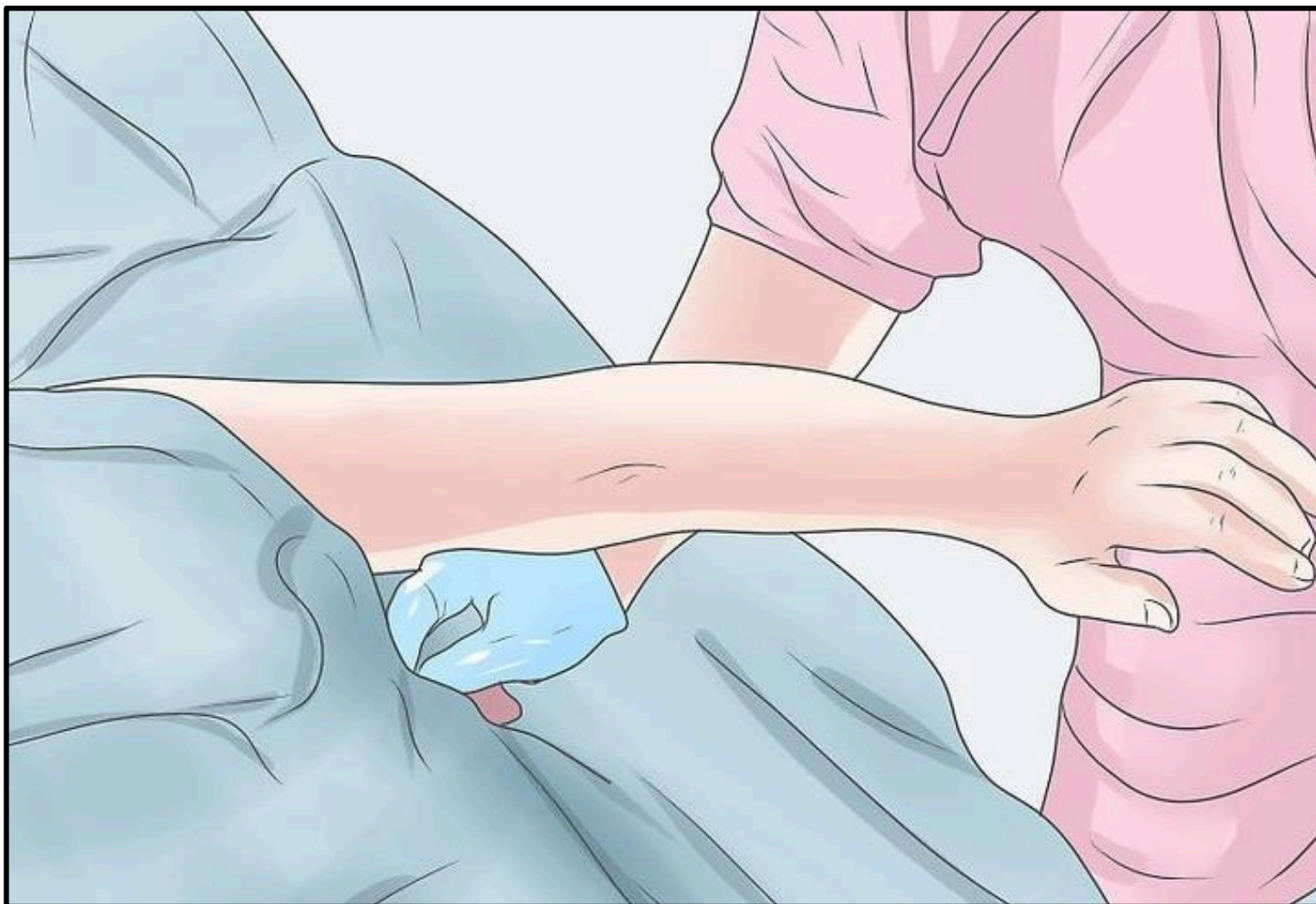
- Lembre-se de alternar entre as duas toalhas de rosto: use uma para ensaboar e outra para enxaguar. Se as toalhas ficarem sujas, troque-as por outras limpas.
- Torne a encher as bacias conforme necessário.



2 Comece com o rosto do paciente. Delicadamente lave o rosto, orelhas e o pescoço dele com água e sabão. Enxágue o sabonete com uma toalha de rosto diferente. Seque a área limpa com outra toalha.



3 Lave o cabelo do paciente. Com cuidado, erga a cabeça dele e coloque-a sobre a bacia para lavar cabelos. Molhe os fios derramando água sobre a cabeça, tomando cuidado para não cair nos olhos. Use o xampu e enxágue. Seque os cabelos com leves toques com uma toalha seca.



4 Lave o ombro e o braço esquerdo do paciente. Dobre o lençol que cobre o lado esquerdo do corpo até a altura do quadril. Coloque uma toalha debaixo do braço exposto. Lave e enxágue o ombro, a axila, o braço e a mão o paciente. Seque as áreas molhadas com uma toalha.

- Seque completamente as áreas lavadas, especialmente a axila, para evitar irritação e a proliferação de bactérias.
- Recoloque o lençol para manter o paciente aquecido.



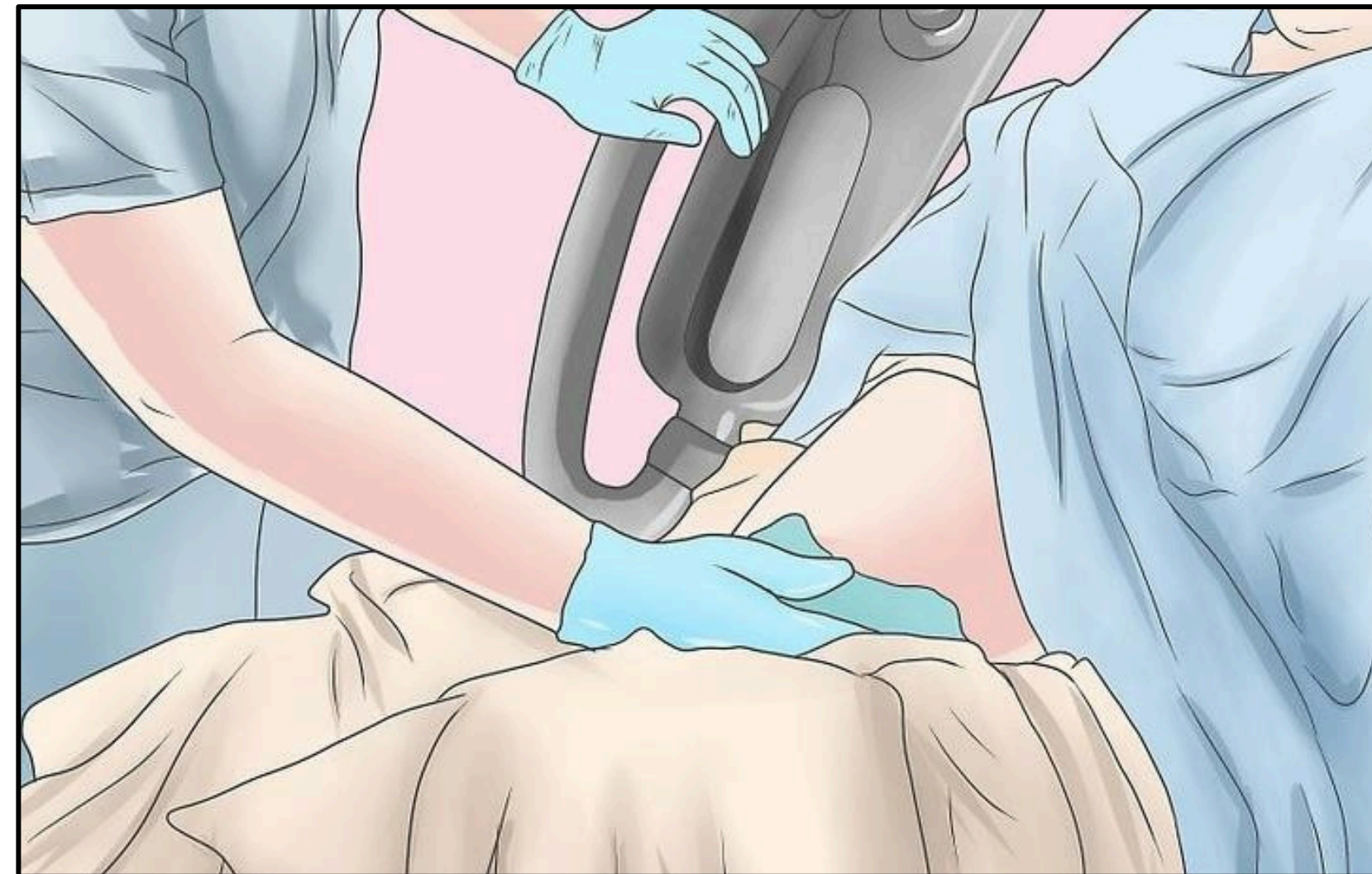
5 Lave o ombro e o braço direito. Dobre o lençol para expor o lado direito. Coloque a toalha debaixo do outro braço e repita o procedimento, lavando, enxaguando e secando o ombro, axila, braço e mão direita.

- Seque as áreas lavadas totalmente, principalmente a axila, para evitar irritação e aumento das bactérias.
- Cubra novamente o paciente com o lençol para que ele não sinta frio.



6 Lave o torso do paciente. Dobre o lençol até a cintura e gentilmente lave e enxágue o tórax, a barriga e as laterais do corpo. Certifique-se de limpar cuidadosamente entre quaisquer dobrinhas da pele do paciente, já que as bactérias tendem a ficar presas nessas áreas. Seque o torso com cuidado, principalmente entre as dobras.

- Recoloque o lençol sobre o paciente para mantê-lo aquecido.



7 Lave as pernas do paciente. Descubra a perna direita até a altura da cintura, enxágue e seque a perna e o pé. Torne a perna direita e retire o lençol da esquerda. Lave, enxágue e seque a perna e o pé. Cubra a parte inferior do corpo.

Parte
3

Lavando as costas e as partes íntimas



1 Esvazie as bacias e torne a enchê-las com água limpa. Já que aproximadamente metade do corpo do paciente está limpa agora, este é um bom momento para trocar a água.



2 Peça ao paciente para ficar de lado se for possível. Você pode ter que auxiliar a pessoa. Certifique-se de que ele não esteja perto demais da beirada da cama.



3 **Lave as costas e as nádegas do paciente.** Dobre o lençol para expor toda a parte traseira do corpo. Lave, enxágue e seque a parte de trás do pescoço, as costas, as nádegas e as partes das pernas que você possa ter pulado.



4 **Lave a área genital e o ânus.** Coloque luvas descartáveis de látex. Erga a perna da pessoa e lave de frente para trás. Use uma toalha de rosto limpa para enxaguar a área. Assegure-se de limpar completamente entre as dobras e secar o local da mesma forma.

- Você deve lavar atrás dos testículos nos pacientes do sexo masculino. Lave os lábios vaginais das pacientes mulheres, mas não há necessidade de limpar a vagina.^[3]
- Essa parte do corpo deve ser lavada todos os dias, mesmo quando você não der um banho completo.



Cabe ressaltar que a grande maioria dos pacientes considera essa situação do banho bastante constrangedora, pois a incapacidade de realizar os próprios cuidados desperta sentimentos de impotência e vergonha, sobretudo porque a intimidade é invadida.

5 Torne a vestir o paciente. Quando terminar, vista a pessoa com roupas limpas ou um roupão. Primeiramente, recoloque a camisa, mantendo o lençol sobre as pernas dela. Então remova o lençol e recoloque as roupas íntimas e as calças.

- A pele do idoso tende a ficar ressecada, portanto provavelmente você terá que aplicar loção nos braços e pernas antes de colocar as roupas.
- Penteie os cabelos do paciente e aplique cosméticos e outros produtos para o corpo de acordo com as preferências da pessoa.

Banho de Leito

- ❑ A secagem deve ser criteriosa, principalmente nas pregas cutâneas, espaços interdigitais e genitais, base dos seios e do abdome em obesos, evitando a umidade da pele, que propicia proliferação de microrganismos e pode provocar assaduras.
- ❑ Na higiene íntima do sexo feminino, a limpeza deve ser realizada no sentido ântero-posterior; no masculino, o prepúcio deve ser tracionado, favorecendo a limpeza do meato urinário para a base da glândula, removendo sujidades (pêlos, esmegma, urina, suor) e inibindo a proliferação de microrganismos.

CONFORTO

Dentro da temática conforto aspectos relacionados ao ambiente do paciente estão presentes como: o ambiente do paciente, ou seja, o quarto o que inclui aspectos relacionados as paredes, pisos, iluminação, controle do clima, mobiliário, etc.



paciente recebe cuidados e do mobiliário que é parte do mesmo.

Definição de unidade de internação:

- É o conjunto de elementos destinados a acomodações do paciente internado e que englobam facilidades adequadas a prestação de cuidados necessários a um bom atendimento (Ministério da Saúde).

É o conjunto de espaços e móveis destinados a cada paciente;
Diferem de hospital para hospital mas basicamente, consta de:

- Cama com colchão
- Mesa de cabeceira
- Cadeira ou poltrona

- Campainha
- Mesa de refeições
- Escadinha
- Régua de gases

Paredes

Pesquisas indicam que cores como o azul, cor de malva e verde claro promovem sensação de relaxamento. Quando não utilizados com exclusividade, são integradas ao papel de parede, parte superior de forro e outros elementos nas paredes.



A disposição dos móveis deverão ser de maneira que permita boa circulação ao redor.

Iluminação

Uma iluminação adequada, natural e artificial é importante para o conforto dos pacientes e dos profissionais de saúde. Os novos prédios estão sendo construídos com janelas maiores, átrios, clarabóias e pátios internos para facilitar a exposição à luz solar e como técnica de redução de estresse.

Temperatura

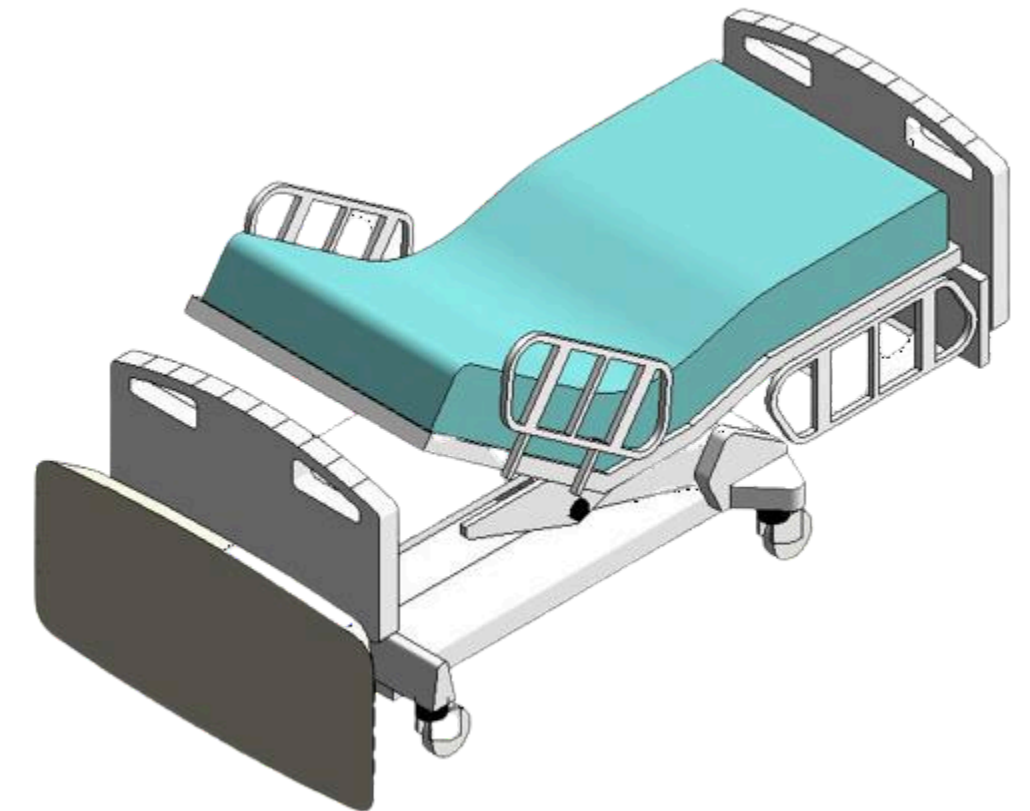
Situa-se entre 20°C a 23°C, prédios novos termostatos individuais nos quartos.

Para assegurar bem-estar ao paciente, muitas instituições de saúde possuem ar condicionado.

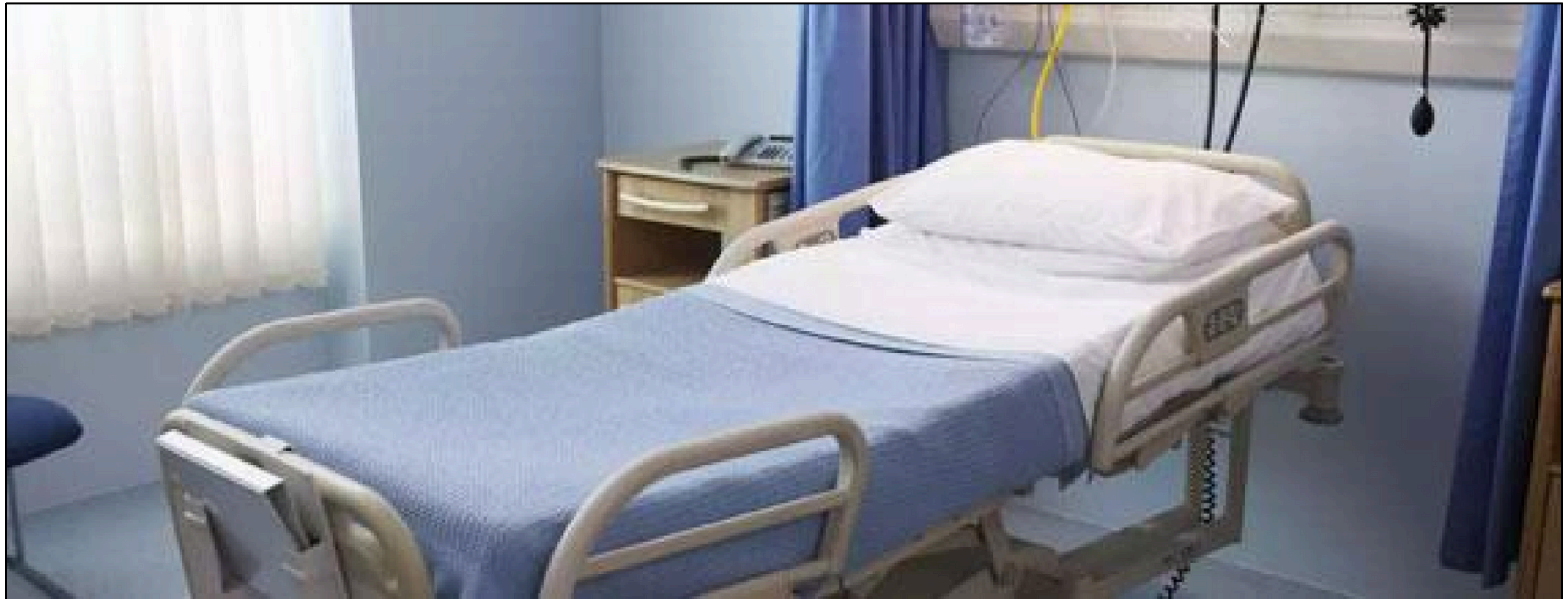
A Cama

Os leitos hospitalares são ajustáveis, o que significa que a altura e a posição da cabeceira podem ser mudadas elétricas ou manualmente.

O ajuste do leito pode promover conforto, facilitar o autocuidado ou uma posição terapêutica.



- Cama fechada: É aquela que está desocupada, aguardando chegada (admissão) do paciente.



- Cama aberta: É aquela que está sendo ocupada por um paciente que pode deambular.



- Cama para operado: É realizada para receber o paciente que está na sala de cirurgia sob anestesia.

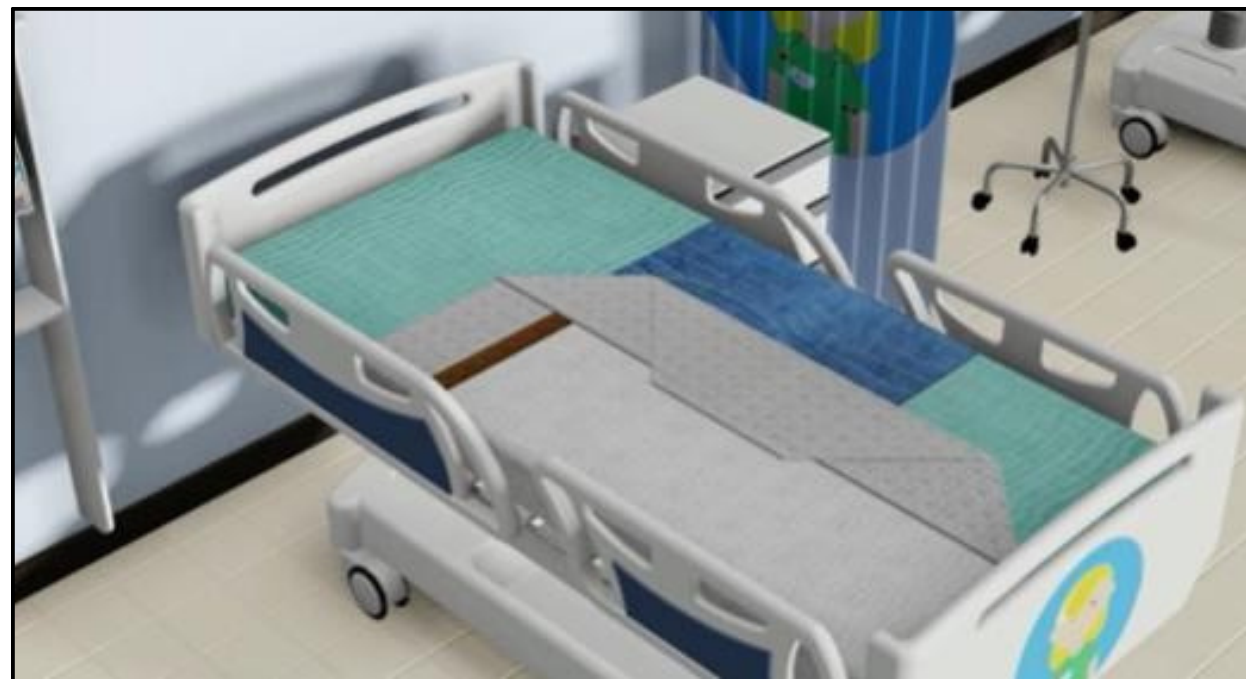
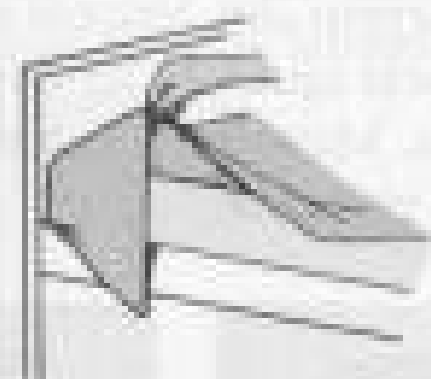
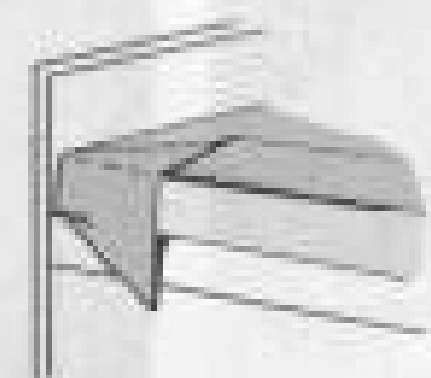


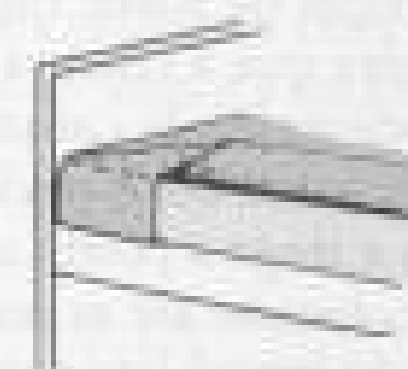
Figura 1: Dobra do canto chanfrado ou prega triangular



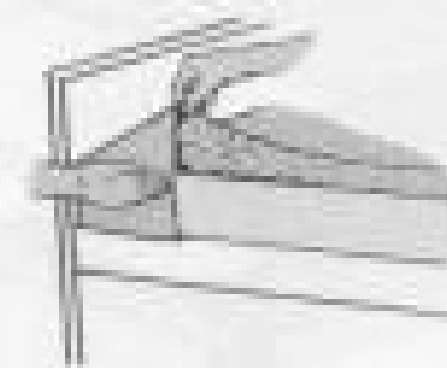
PASSO 17c Pegando a ponta superior do lençol.



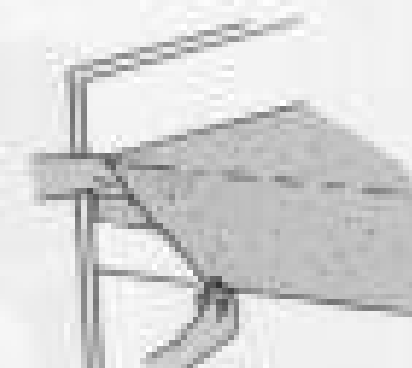
PASSO 17d Lençol no colchão em uma dobra triangular.



PASSO 17e Ponta inferior do lençol presa sob o colchão.



A



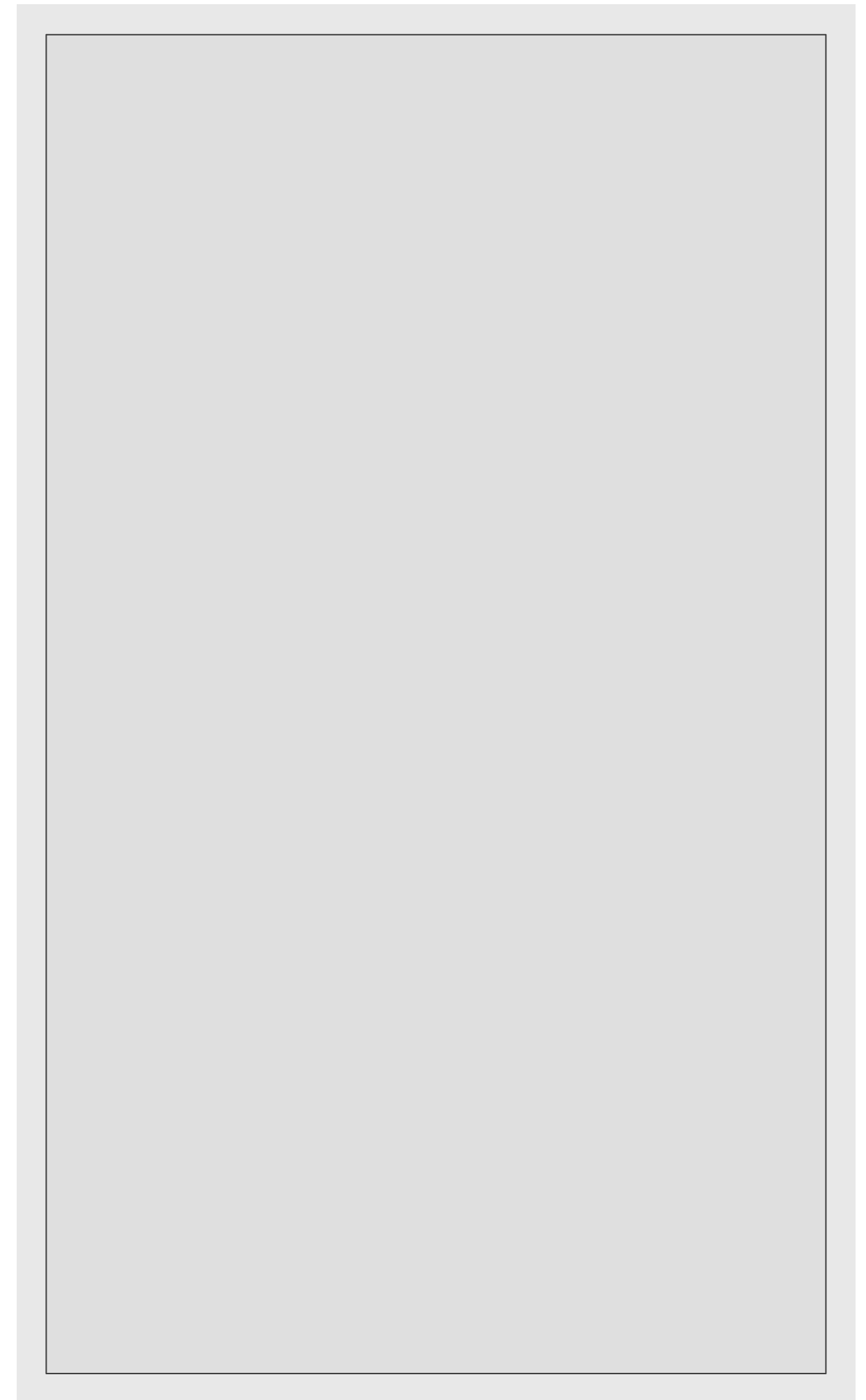
B



C

PASSO 17f A e B, Dobra triangular colocada na lateral do colchão. C, Lençol preso sob o colchão.

Obrigada!



Bibliografia

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. Norma Regulamentadora No. 32 (NR-32).

Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaosespecificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normaregulamentadora-no-32-nr-32>. Acesso em: 12/03/2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC N°42, de 25 de Outubro de 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0042_25_10_2010.html. Acesso em: 12/03/2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Segurança do Paciente: Higienização das mãos. Disponível em: https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/paciente_hig_maos.pdf. Acesso em: 12/03/2022.

GALLAS, Samanta Rauber; FONTANA, Rosane Teresinha. Biossegurança e a enfermagem nos cuidados clínicos: contribuições para a saúde do trabalhador. Rev. bras. enferm., Brasília, v. 63, n. 5, p. 786-792, Oct. 2010.

Teixeira P, Valle S. Biossegurança. Rio de Janeiro (RJ): FIOCRUZ; 2010.

Higienização das mãos em serviço de saúde, ANVISA, 2007.

Técnica cirúrgica: Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia, Goffi, 4ª edição, 2006.

PORTAL EDUCAÇÃO. Higiene Corporal do Paciente. Disponível em: <https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/higiene-corporal-do-paciente/30451>. Acesso em 13/03/2022.

TV UEL. Projeto Uel oferece higiene bucal a pacientes internados na UTI do Hospital Universitário. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aQeAd-4kNsA>. Acesso em 13/03/2022.

PORATL HOSPITAIS BRASIL. O banho no leito e os cuidados com o paciente acamado. Disponível em: <https://portalhospitaisbrasil.com.br/o-banho-no-leito-e-os-cuidados-com-o-paciente-acamado/>. Acesso em 13/03/2022.

WIKI HOW. Como dar um banho no leito. Disponível em: <https://pt.wikihow.com/Dar-um-Banho-no-Leito>. Acesso em 13/03/2022.

ENFERMAGEM ILUSTRADA. Os tipos de banho em pacientes hospitalares. Disponível em: <https://enfermagemilustrada.com/os-tipos-de-banho-em-pacientes-hospitalares/>. Acesso em 13/03/2022.

SILVA, M.O. Fundamentos da Enfermagem. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/0000804014/fundamentos-da-enfermagem-aula-2>. Acesso em 12/03/2022.